

PAUSE CARDIO

Nouveautés de la semaine du 26 septembre 2026

2 nouveautés cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE À connaître Analyse groupée de 6 essais randomisés**Intracranial haemorrhage following tenecteplase fibrinolysis for acute myocardial infarction.****European Heart Journal** · 21 septembre 2026 · Données individuelles de 6 essais randomisés, 15 954 patients

Cette analyse groupée sur données individuelles réunit six essais randomisés de fibrinolyse par ténecteplase, à dose ajustée au poids, dans l'infarctus avec sus-décalage de ST, soit 15 954 patients, dont 169 ont présenté une hémorragie intracrânienne. Au-delà de 110 mmHg de pression artérielle systolique, chaque millimètre de mercure supplémentaire s'accompagne d'une augmentation relative de 2 % du risque d'hémorragie (OR ajusté 1,02 ; IC95 % 1,01–1,03), et cette hausse s'accroît nettement au-delà de 160 mmHg. L'effet de l'âge dépend de la dose : le risque croît d'environ 1 % par année d'âge à la dose de 30 mg, et de près de 7 % par année à la dose de 50 mg. Le sexe féminin et un poids plus faible sont aussi associés à un risque plus élevé.

En pratique : quand une fibrinolyse par ténecteplase est décidée faute d'angioplastie primaire accessible à temps, deux facteurs modifiables méritent attention avant l'injection : la pression artérielle systolique, dont l'association avec le risque d'hémorragie commence dès 110 mmHg et s'accroît nettement au-delà de 160 mmHg, et la dose chez le sujet âgé, puisqu'une dose pleine amplifie l'effet de l'âge. Les auteurs présentent l'optimisation tensionnelle et la réduction de dose comme des pistes pour diminuer les hémorragies, non comme des conduites démontrées par un essai. Les femmes et les patients de faible poids appellent une vigilance particulière.

[Article original](#)**INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL** Veille Sous-étude d'essai randomisé · SMART-CHOICE 3**Clopidogrel monotherapy versus aspirin monotherapy in females and males after percutaneous coronary intervention: a sex-stratified analysis of the SMART-CHOICE 3 trial.****EuroIntervention** · 21 septembre 2026 · Sous-étude présélectionnée, 5 506 patients

Cette sous-étude présélectionnée de l'essai SMART-CHOICE 3 porte sur 5 506 patients à haut risque de récurrence ischémique qui, après la durée standard de bithérapie antiplaquettaire suivant une angioplastie, ont été randomisés entre clopidogrel seul et aspirine seule. Les 1 002 femmes avaient un profil de risque plus élevé que les hommes, mais l'incidence du critère principal, qui associe décès toutes causes, infarctus du myocarde et AVC, ne différait pas significativement entre les sexes. Le clopidogrel a réduit ce critère chez les femmes (4,3 % contre 9,4 % ; HR ajusté 0,45 ; IC95 % 0,24–0,85), alors que la réduction n'atteignait pas la significativité chez les hommes (4,4 % contre 6,0 % ; HR ajusté 0,77 ; IC95 % 0,56–1,07). L'interaction entre le sexe et le traitement n'est pas significative ($p = 0,288$).

En pratique : chez un patient à haut risque ischémique qui a terminé sa bithérapie après angioplastie, le choix du clopidogrel seul plutôt que de l'aspirine seule ne dépend pas du sexe : l'effet va dans le même sens chez la femme et chez l'homme, et cette analyse ne donne pas d'argument pour traiter les femmes autrement. La réduction plus marquée observée chez les femmes reste un résultat de sous-groupe, sans interaction significative, et ne justifie pas à elle seule une stratégie différenciée.

[Article original](#)